

	โรงพยาบาลปากช่องนานา แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก (Clinical Nursing Practice Guideline : CNPG)		จำนวน 17 หน้า
	เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยโรค Thalassemia ในเด็ก	หน่วยงานที่ใช้ หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม	
	รหัสเอกสาร CNPG-Thalassemia	วันที่เริ่มใช้	
หน่วยงาน : หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม		ผู้จัดทำ : (นางสาวณิศาภัสสุภา โกยทา) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (นางสาวสุภาวิตา ชาวเสมา) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
ผู้ทบทวน (นางสาวนราวดี ปู่สูงเนิน) ตำแหน่ง หัวหน้าพยาบาล		ผู้อนุมัติ : (นายสกล ด้านภักดี) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากช่องนานา	

การควบคุมระบบเอกสารคุณภาพ

ประวัติการแก้ไข

จำนวน หน้า

[illegible]

	แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก (Clinical Nursing Practice Guideline : CNPG)	เลขหน้า 1/17
	เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยโรค Thalassemia ในเด็ก	รหัสเอกสาร CNPG-Thalassemia

1. วัตถุประสงค์ (Purpose)

1. เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพและบุคลากรทางการแพทย์มีแนวทางในการประเมิน วางแผน และให้การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรค Thalassemia ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเป็นมาตรฐานเดียวกัน
2. เพื่อให้ผู้ป่วยและผู้ดูแลได้รับความรู้เกี่ยวกับโรค การดูแลตนเอง การรับประทานยา และการมาตรวจตามนัด
3. เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรค Thalassemia และการได้รับเลือด เช่น ภาวะธาตุเหล็กเกิน (Iron Overload) ปฏิกิริยาจากการรับเลือด (Transfusion Reaction) และภาวะหัวใจล้มเหลว
4. เพื่อลดอัตราการกลับมารักษาซ้ำ (Re-admission) และลดภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการได้รับเลือดไม่เพียงพอ

2. เป้าหมายของการใช้ (Target Population)

แนวปฏิบัติการพยาบาลนี้ใช้สำหรับผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค Thalassemia ทุกชนิด ที่เข้ารับการรักษานในหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลปากช่องนานา โดยครอบคลุม :

- ผู้ป่วย Thalassemia ที่มาเพื่อรับเลือด (LPRC/PRC Transfusion) ตามระยะเวลาที่กำหนด
- ผู้ป่วย Thalassemia ที่มีภาวะแทรกซ้อน เช่น ภาวะซีดเฉียบพลัน ภาวะหัวใจล้มเหลว ภาวะธาตุเหล็กเกิน
- ผู้ป่วยเด็กอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 15 ปี ที่ได้รับการวินิจฉัย Thalassemia ทุกชนิด
- ผู้ดูแลหลัก (Primary Caregiver) ที่รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยที่บ้าน

3. พยาธิสรีรวิทยาของโรค (Pathophysiology)

3.1 ความหมายและชนิดของโรค Thalassemia

โรค Thalassemia เป็นโรคเลือดพันธุกรรมที่ถ่ายทอดแบบ Autosomal Recessive ทำให้มีความผิดปกติในการสร้างสายโปรตีน Globin ของฮีโมโกลบิน (Hemoglobin; Hb) ส่งผลให้เม็ดเลือดแดงแตกง่าย (Hemolysis) และเกิดภาวะซีดเรื้อรัง (Chronic Hemolytic Anemia)

โรค Thalassemia แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่

1. Alpha-Thalassemia: เกิดจากความผิดปกติของยีน Alpha-Globin บนโครโมโซมที่ 16

	แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก (Clinical Nursing Practice Guideline : CNPG)	เลขหน้า 2/17
	เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยโรค Thalassemia ในเด็ก	รหัสเอกสาร CNPG-Thalassemia

พบบ่อยในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แบ่งเป็น Silent carrier, Alpha-Thal trait, Hb H disease, และ Hb Bart's hydrops fetalis

2. Beta-Thalassemia: เกิดจากความผิดปกติของยีน Beta-Globin บนโครโมโซมที่ 11 แบ่งเป็น Beta-Thal minor (trait), Beta-Thal intermedia, และ Beta-Thal major (Cooley's anemia)

3.2 กลไกการเกิดโรค

เมื่อสายโปรตีน Globin สร้างได้ลดลงหรือผิดปกติ ทำให้โมเลกุล Hb ไม่สมดุล สาย Globin ส่วนเกินจะตกตะกอนในเม็ดเลือดแดง ก่อให้เกิดการทำลายเม็ดเลือดแดงทั้งใน Bone marrow (Ineffective erythropoiesis) และในกระแสเลือด (Peripheral hemolysis) ภาวะ Ineffective erythropoiesis กระตุ้นให้ไขกระดูกสร้างเม็ดเลือดมากขึ้น (Compensatory hyperplasia) ทำให้เกิดการโป่งพองของกระดูก โดยเฉพาะกระดูกใบหน้าและกะโหลกศีรษะ (Thalassemic facies) นอกจากนี้ยังเกิด Extramedullary hematopoiesis ที่ตับและม้าม ทำให้ตับและม้ามโต (Hepatosplenomegaly) การดูดซึม Iron เพิ่มขึ้นจากลำไส้ ร่วมกับ Iron ที่ได้รับจากการรับเลือดซ้ำๆ ทำให้เกิด Iron Overload สะสมที่หัวใจ ตับ และอวัยวะต่างๆ ส่งผลให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลว ตับแข็ง และเบาหวาน

3.3 Hb H disease with Constant Spring (Hb H CS)

Hb H with Constant Spring (CS) เป็น Alpha-Thalassemia ชนิดรุนแรงปานกลาง เกิดจากการที่มี 3 ยีน Alpha-Globin ที่ผิดปกติ โดยมียีน Alpha CS (Non-deletion mutation) หนึ่งตัว ส่งผลให้สร้าง Alpha-Globin ได้น้อยมาก ผู้ป่วยมักมีค่า Hb 6-9 g/dL และต้องการการถ่ายเลือดเป็นระยะๆ โดยเฉพาะในช่วงที่มีการติดเชื้อหรือภาวะเครียดของร่างกาย

4. นิยามศัพท์เฉพาะ (Definitions)

LPRC (Leukocyte-Poor Red Cell): เม็ดเลือดแดงที่ผ่านการกรองเม็ดเลือดขาวออกแล้ว ลดความเสี่ยงต่อ Febrile Non-Hemolytic Transfusion Reaction (FNHTR) และการสร้าง Alloantibody ใช้สำหรับผู้ป่วยที่ต้องรับเลือดซ้ำหลายครั้ง

PRC (Packed Red Cell): เม็ดเลือดแดงเข้มข้น ที่ผ่านการแยกพลาสมาออกบางส่วน Hematocrit ประมาณ 65-80% ใช้รักษาภาวะซีดชนิดต่างๆ

	แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก (Clinical Nursing Practice Guideline : CNPG)	เลขหน้า 3/17
	เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยโรค Thalassemia ในเด็ก	รหัสเอกสาร CNPG-Thalassemia

Iron Overload: ภาวะธาตุเหล็กเกินในร่างกาย วัดโดย Serum Ferritin (ค่าปกติ 12-200 ng/mL) เมื่อ Serum Ferritin สูงกว่า 1,000 ng/mL ต้องพิจารณาเริ่ม Chelation therapy ด้วยยา Deferasirox (Jadenu) หรือ Deferoxamine

Chelation Therapy: การรักษาภาวะธาตุเหล็กเกินด้วยยาที่จับ Iron แล้วขับออกทางปัสสาวะและอุจจาระ ยาที่ใช้ได้แก่ Deferasirox (ชนิดรับประทาน) และ Deferoxamine (ชนิดฉีด)

Hemoglobin (Hb): โปรตีนในเม็ดเลือดแดงที่ทำหน้าที่ลำเลียงออกซิเจน ค่าปกติในเด็ก: ทารกแรกเกิด 14-24 g/dL, เด็ก 1-6 ปี 11-14 g/dL, เด็ก 6-12 ปี 11.5-15.5 g/dL

Hematocrit (HCT) : อัตราส่วนปริมาตรของเม็ดเลือดแดงต่อเลือดทั้งหมด ค่าปกติในเด็ก: 33-45%
 MEWS/POPS Score: Modified Early Warning Score / Pediatric Observation Priority Score เครื่องมือประเมินความรุนแรงของอาการในเด็ก ใช้ติดตามการเปลี่ยนแปลงอาการก่อนเกิดภาวะวิกฤต

Transfusion Reaction: ปฏิกริยาที่เกิดขึ้นระหว่างหรือหลังได้รับเลือด ได้แก่ Febrile Non-Hemolytic, Allergic/Urticarial, Hemolytic (Acute/Delayed), TRALI, TACO โดย TACO (Transfusion-Associated Circulatory Overload) เป็นภาวะที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยที่มีโรคหัวใจอยู่เดิม

X-match (Crossmatch): การทดสอบความเข้ากันได้ระหว่างเลือดผู้ให้และผู้รับ เพื่อป้องกัน Hemolytic Transfusion Reaction ต้องทำการให้เลือดทุกครั้ง

Splenomegaly: ม้ามโต พบบ่อยใน Thalassemia เนื่องจากม้ามทำหน้าที่กำจัดเม็ดเลือดแดงผิดปกติ เมื่อม้ามโตมากอาจต้องทำ Splenectomy

5. แนวทางการดูแลรักษาและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Treatment Guidelines)

งานวิจัยเรื่อง The effects of implementing teaching programs to develop knowledge and responsibilities of caregivers attending to children with Thalassemia Sakaeo at the Crown Prince Hospital in Thailand: ผลของโปรแกรมการสอนต่อความรู้และพฤติกรรมการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยเด็กโรคธาลัสซีเมีย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

ผู้นิพนธ์ผู้รับผิดชอบ : กรองแก้ว ทรัพย์ประเสริฐ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก, บุรพาเวศสาร ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2568

	แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก (Clinical Nursing Practice Guideline : CNPG)	เลขหน้า 4/17
	เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยโรค Thalassemia ในเด็ก	รหัสเอกสาร CNPG-Thalassemia

กำหนดกรอบและวัตถุประสงค์ของการสืบค้น โดยใช้แนวคิด PICO Framework ระบุคำสำคัญตาม รายละเอียด ดังนี้

P (Participant) : ผู้ดูแลเด็กป่วยโรคธาลัสซีเมีย ที่มารับการรักษาโดยให้เลือดอย่างสม่ำเสมอทุกราย จำนวน 129 ราย

I (Intervention) : เปรียบเทียบความรู้และพฤติกรรมการดูแลของผู้ดูแลเด็กป่วยโรคธาลัสซีเมียก่อนและหลังที่ได้รับโปรแกรมการสอน

C (Comparison) : กลุ่มตัวอย่าง ผู้ดูแลเด็กป่วยโรคธาลัสซีเมียทุกรายที่มารับการรักษาโดยให้เลือดอย่างสม่ำเสมอจำนวน 14 ราย จากวิธีการเข้ารับโปรแกรมการสอนผู้ดูแลเด็กป่วยโรคธาลัสซีเมียเรื่องโรคธาลัสซีเมียและการให้คำแนะนำผู้ดูแลก่อนจำหน่ายผู้ป่วยกลับบ้าน

1. control group ผู้ดูแลเด็กป่วยโรคธาลัสซีเมีย ที่มารับการรักษาโดยให้เลือดอย่างสม่ำเสมอ
2. Observation group ผู้ดูแลเด็กป่วยโรคธาลัสซีเมีย ที่มารับการรักษาโดยให้เลือดได้รับโปรแกรมการสอน
 - 2.1 โปรแกรมการสอนความรู้และพฤติกรรมการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยเด็กโรคธาลัสซีเมีย เป็นโปรแกรมเนื้อหาที่พัฒนาขึ้นใหม่จากการทบทวนวรรณกรรมจาก Thalassemia foundation of thailand, 202014 ร่วมกับ ประยุกต์หลักการสอน 9 ประการ ตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ของกาเย่8 ได้แก่

- 1) เร่งเร้าความสนใจ
- 2) ชี้แจงวัตถุประสงค์
- 3) ทบทวนความรู้เดิม
- 4) นำเสนอเนื้อหาใหม่
- 5) ชี้แนะแนวทางการเรียนรู้
- 6) กระตุ้นการตอบสนอง
- 7) ให้ข้อมูลย้อนกลับ
- 8) ทดสอบความรู้ใหม่

9) สรุปและนำไปใช้โปรแกรมการสอนที่ใช้ในการดำเนินการทดลองครั้งนี้มีจำนวน 4 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 แนะนำตัวชวนพูดคุยให้เห็นถึงความสำคัญของการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคธาลัสซีเมีย ประเมินความรู้และพฤติกรรมการดูแลของผู้ดูแล (pre-test) และให้โปรแกรมการสอนรับชมการตูนแอนิเมชัน เรื่อง โรคธาลัสซีเมีย หลังจากนั้นให้ความรู้ สรุปเนื้อหา และเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัย

	แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก (Clinical Nursing Practice Guideline : CNPG)	เลขหน้า 5/17
	เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยโรค Thalassemia ในเด็ก	รหัสเอกสาร CNPG-Thalassemia

ครั้งที่ 2 ก่อนการจำหน่ายกลับบ้าน โดยการทบทวนความรู้จากครั้งที่ 1 และมอบคู่มือการดูแลเด็กโรคธาลัสซีเมีย เพื่อให้ผู้ดูแลนำกลับไปทบทวนที่บ้าน

ครั้งที่ 3 ภายหลังการจำหน่าย 15 วันจัดกิจกรรม โดยการโทรศัพท์เพื่อกระตุ้นเตือนพฤติกรรมดูแลของผู้ดูแล พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัย

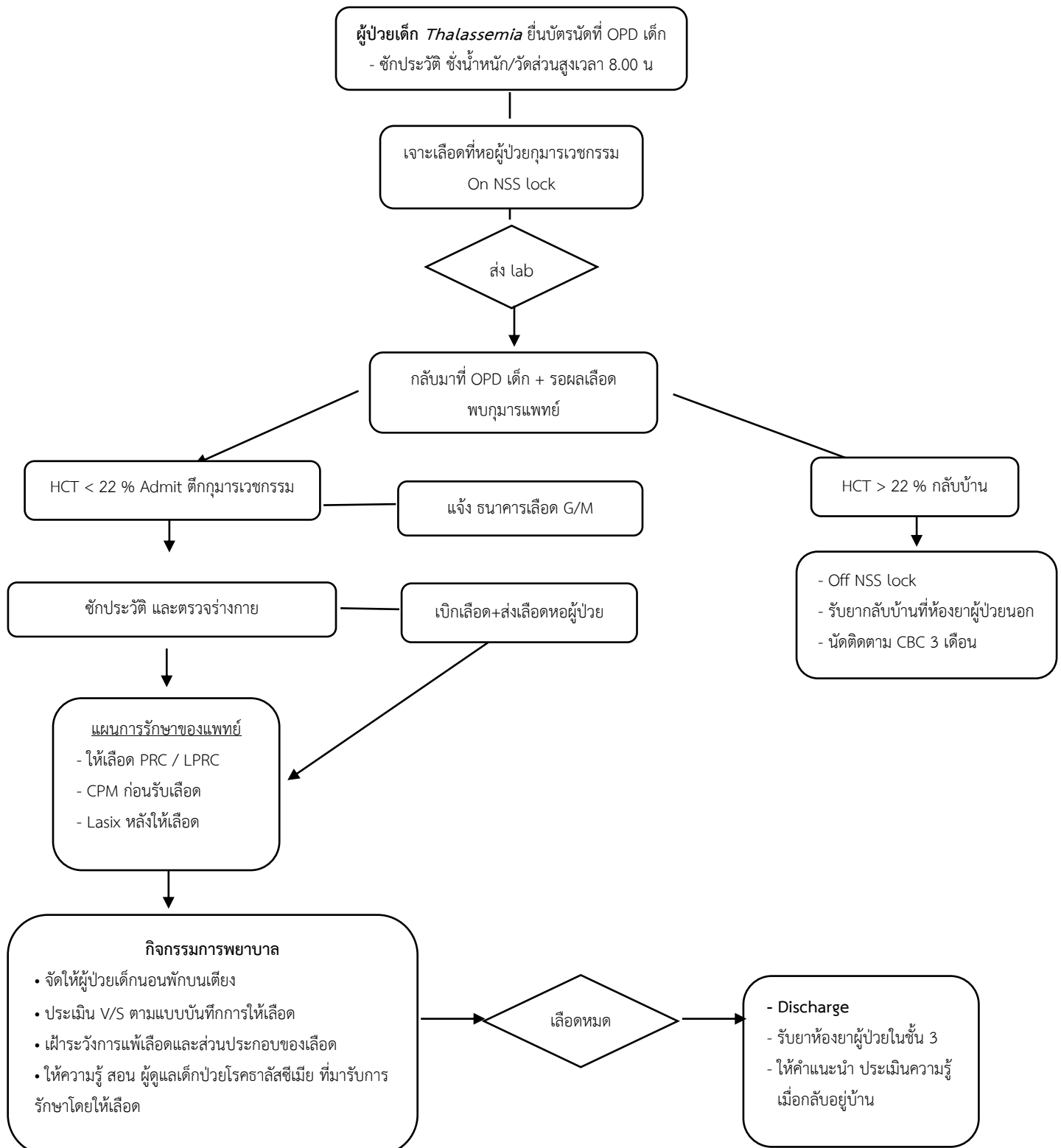
ครั้งที่ 4 เมื่อผู้ดูแลพาผู้ป่วยมารับการรักษาโดยการให้เล็ดทวนความรู้เดิมจากที่ได้รับโปรแกรมการสอนการดูแลเด็กป่วยโรคธาลัสซีเมีย และซักถาม

O (Outcome) : ผลการศึกษาโปรแกรมการสอนที่ออกแบบตามแนวคิดของกาเย่ สามารถเพิ่มความรู้และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ดูแลผู้ป่วยเด็กโรคธาลัสซีเมียได้อย่างมีนัยสำคัญ ผู้ดูแลมีความเข้าใจในโรคมมากขึ้น และสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น หลังได้รับโปรแกรมการสอนฯ ผู้ดูแลเด็กป่วยโรคธาลัสซีเมียมีคะแนนความรู้ และพฤติกรรมดูแลผู้ป่วยเด็กโรคธาลัสซีเมียเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ($p = 0.001$ และ $p = 0.020$ ตามลำดับ)

6. วิธีดำเนินการ

	แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก (Clinical Nursing Practice Guideline : CNPG)	เลขหน้า 6/17
	เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยโรค Thalassemia ในเด็ก	รหัสเอกสาร CNPG-Thalassemia

6.1 Flow Chart ระบบงาน



	แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก (Clinical Nursing Practice Guideline : CNPG)	เลขหน้า 7/17
	เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยโรค Thalassemia ในเด็ก	รหัสเอกสาร CNPG-Thalassemia

6.2 ขั้นตอนแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก

ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลที่ 1

- มีภาวะซีดเรื้อรัง เนื่องจากการสลายตัวของเม็ดเลือดแดงผิดปกติจากพยาธิสภาพของโรคธาลัสซีเมีย

ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลที่ 2

- เสี่ยงต่อภาวะเหล็กเกินในร่างกาย เนื่องจากการรับเลือดซ้ำๆ และการดูดซึมธาตุเหล็กเพิ่มขึ้น

ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลที่ 3

- ความทนต่อกิจกรรมลดลง เนื่องมาจากภาวะซีดเรื้อรังและออกซิเจนไปเลี้ยงเนื้อเยื่อไม่เพียงพอ

ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลที่ 4

- เสี่ยงต่อการติดเชื้อ เนื่องจากภูมิคุ้มกันบกพร่องและการเจาะหลอดเลือดซ้ำๆ

ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลที่ 5

- ความรู้ไม่เพียงพอเกี่ยวกับโรคและการดูแลตนเอง เนื่องจากขาดข้อมูลและประสบการณ์ในการดูแลโรคธาลัสซีเมีย

ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลที่ 6

- ความวิตกกังวล เนื่องจากการเจ็บป่วยเรื้อรัง ความไม่แน่นอนของโรค และภาระค่าใช้จ่าย

ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลที่ 7

- แผนการจำหน่ายกลับบ้าน (Discharge Planning) — D-METHOD)



แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก
(Clinical Nursing Practice Guideline : CNPG)

เลขหน้า 8/17

เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยโรค Thalassemia ในเด็ก

รหัสเอกสาร CNPG-Thalassemia

ข้อวินิจฉัยการพยาบาล	ข้อมูลสนับสนุน	วัตถุประสงค์ทางการพยาบาล	เกณฑ์การประเมินผล	กิจกรรมการพยาบาล
1. มีภาวะซีดเรื้อรัง เนื่องจากการสลายตัวของเม็ดเลือดแดงผิดปกติ จากพยาธิสภาพธาลัสซีเมีย	- S: "เหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย ใจสั่น เวลาเดินไกลๆ" - O: Hb < 7 g/dL, Hct < 21% - O: ผิวซีด เยื่อบุตาซีดริมฝีปากซีด - O: PR >100 bpm RR < 18 bpm SpO2 < 95 % - O: ตับ/ม้ามโต คลำได้ใต้ชายโครง - O: MCV < 60 fL, MCH < 20 pg	1.ผู้ป่วยมี Hb $\geq$ 8-9.5 g/dL หลังได้รับเลือด 2.ผู้ป่วยไม่มีอาการเหนื่อยหอบขณะพัก 3.V/Sอยู่ในเกณฑ์ปกติตามวัย 4.ผู้ป่วย/ผู้ปกครองเข้าใจสาเหตุของภาวะซีด	- Hb $\geq$ 8-9.5 g/dL ภายใน 24 ชม.หลังให้เลือด - SpO2 $\geq$ 95% ขณะหายใจอากาศปกติ -ไม่มีอาการหายใจเหนื่อยขณะพัก - V/S อยู่ในเกณฑ์ปกติตามวัย - ผิวและเยื่อบุตาสีดีขึ้น	1. ประเมิน V/S, SpO2, ระดับความซีด (ผิว เยื่อบุตา) ทุก 4 ชม. 2. ตรวจสอบ CBC และ Cross-match ก่อนให้เลือดทุกครั้ง 3. ดูแลให้ PRC/LPRC ตามแผนการรักษา 4. ให้เลือดในอัตราที่เหมาะสมตามแผนการรักษา 5. สังเกตปฏิกิริยาการให้เลือด ตามแบบบันทึกการให้เลือด เช่น ไข้ หนาวสั่น ผื่น ปวดหลัง ปัสสาวะสีโคล่ 6. จัดทำนอนศีรษะสูง 30-45 องศา ลดการทำงานของหัวใจ 7. ให้ O2 therapy if SpO2 < 95% 8. บันทึก Intake-Output ทุก 8 ชม. สังเกตอาการ fluid overload 9. รายงานแพทย์ทันทีหากพบปฏิกิริยาแพ้เลือดและส่วนประกอบของเลือด



แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก
(Clinical Nursing Practice Guideline : CNPG)

เลขหน้า 9/17

เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยโรค Thalassemia ในเด็ก

รหัสเอกสาร CNPG-Thalassemia

ข้อวินิจฉัยการพยาบาล	ข้อมูลสนับสนุน	วัตถุประสงค์ทางการพยาบาล	เกณฑ์การประเมินผล	กิจกรรมการพยาบาล
2. เสี่ยงต่อภาวะเหล็กเกิน ในร่างกายเนื่องจากการรับเลือดซ้ำๆ และการดูดซึมธาตุเหล็กเพิ่มขึ้น	- S: "ลูกได้รับเลือดมาหลายปีแล้ว บางครั้งลืมกินยาขับเหล็ก" - O: Serum Ferritin > 1,000 ng/mL - O: ผิวหนังสีคล้ำ/สีทองแดง - O: ประวัติรับ PRC $\geq$ 8-10 หน่วย/ปี - O: LFT ผิดปกติ (ALT, AST สูง) - O: Echocardiogram: LV dysfunction (กรณีมีภาวะหัวใจ)	1.ผู้ป่วยได้รับยาขับเหล็กถูกต้องครบตามแผนรักษา 2. Ferritin ลดลงหรืออยู่ในเป้าหมาย < 2,500 ng/mL	- ผู้ป่วยได้รับ Deferoxamine ครบตามเวลา - Ferritin < 2,500 ng/mL (เป้าหมายระยะยาว) - LFT, Creatinine ไม่แย่งจากยาขับเหล็ก	1. ดูแลให้ยาขับเหล็กรับประทานและฉีดยาตามแผนรักษา 3. ติดตาม Serum Ferritin ทุก 3 เดือน, LFT, Creatinine, ตรวจปัสสาวะทุก 3 เดือน 4. สังเกตผลข้างเคียง Deferoxamine คลื่นไส้ ปวดท้อง ผื่น ค่าไตสูงขึ้น 5. บันทึกสัญญาณชีพทุกครั้งที่ได้รับเลือด 6. แนะนำหลีกเลี่ยง อาหารเสริมธาตุเหล็ก, วิตามินซีขนาดสูง



แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก
(Clinical Nursing Practice Guideline : CNPG)

เลขหน้า 10/17

เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยโรค Thalassemia ในเด็ก

รหัสเอกสาร CNPG-Thalassemia

ข้อวินิจฉัยการพยาบาล	ข้อมูลสนับสนุน	วัตถุประสงค์ทางการพยาบาล	เกณฑ์การประเมินผล	กิจกรรมการพยาบาล
3. ความทนต่อกิจกรรมลดลงเนื่องจากภาวะซีดเรื้อรังและออกซิเจนไปเลี้ยงเนื้อเยื่อไม่เพียงพอ	- S: "เหนื่อยง่าย เล่นกับเพื่อนไม่ได้นาน ต้องพักบ่อย" - O: เหนื่อยหอบ หลังออกกำลังกายเล็กน้อย - O: HR เพิ่ม > 20% เมื่อทำกิจกรรม - O: Hb < 7 g/dL - O: พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ช้ากว่าวัย	1. ผู้ป่วยทำกิจกรรมประจำวันได้เหมาะสมตามวัย 2. ไม่มีอาการเหนื่อยหอบระหว่างทำกิจกรรมพื้นฐาน 3. ผู้ปกครองวางแผนกิจกรรมได้เหมาะสม	- ไม่เหนื่อยหอบขณะทำกิจกรรมระดับเบา - HR ไม่เพิ่มเกิน 20% จากค่าพื้นฐาน - ผู้ปกครองสาธิตการจัดตารางกิจกรรมได้ - ผู้ป่วยแสดงออกถึงความพึงพอใจในการทำกิจกรรม	1. ประเมินระดับการทนต่อกิจกรรมก่อนและหลังให้เลือด ด้วย 6-minute walk test (เด็กโต) 2. จัดตารางกิจกรรมสลับพักที่เหมาะสม 3. แนะนำสัญญาณเตือนให้หยุดทำกิจกรรมทันที : เหนื่อยมาก ใจสั่น ซีดเพิ่ม วิงเวียน 4. ส่งเสริมกิจกรรมที่เหมาะสมตาม Hb level: Hb > 8 → เดิน เล่นเบาๆ; Hb < 8 → พักบนเตียงเป็นหลัก 5. ประสานส่งกระตุ้นพัฒนาการกรณีพัฒนาการล่าช้า 6. แนะนำผู้ปกครองจัดสิ่งแวดล้อมที่บ้านลดการใช้พลังงาน 7. ประเมินพัฒนาการตามวัย (Denver II) และแจ้งผลให้ผู้ปกครองทราบ



แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก
(Clinical Nursing Practice Guideline : CNPG)

เลขหน้า 11/17

เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยโรค Thalassemia ในเด็ก

รหัสเอกสาร CNPG-Thalassemia

ข้อวินิจฉัยการพยาบาล	ข้อมูลสนับสนุน	วัตถุประสงค์ทางการพยาบาล	เกณฑ์การประเมินผล	กิจกรรมการพยาบาล
4. เสี่ยงต่อการติดเชื้อเนื่องจากภูมิคุ้มกันบกพร่องและการเจาะหลอดเลือดซ้ำๆ	- S: "ลูกป่วยบ่อย มีไข้บ่อย" - O: ประวัติม้ามโต / ตัดม้าม (Splenectomy) - O: WBC อยู่ในระดับต่ำ (Hypersplenism) - O: มีรอยเจาะเลือดหรือสาย IV หลายจุด - O: ยังไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์	1. ผู้ป่วยไม่มีสัญญาณการติดเชื้อระหว่างรับการรักษา เช่น ไข้ ไอ 2. บริเวณ IV site ไม่มีการอักเสบ Phlebitis 3. ผู้ปกครองปฏิบัติสุขอนามัยป้องกันการติดเชื้อได้	- ไม่มีไข้ $> 37.8^{\circ}\text{C}$ ระหว่างนอนโรงพยาบาล - IV site ไม่เกิด Phlebitis , swelling, discharge - WBC ไม่เพิ่มขึ้นผิดปกติ - ผู้ปกครองล้างมือ 7 ขั้นตอนได้ถูกต้อง	1. ปฏิบัติ Hand Hygiene 5 Moments ทุกครั้งก่อน-หลังสัมผัสผู้ป่วย 2. ดูแล IV site ด้วย Aseptic technique เปลี่ยน dressing ทุก 48-72 ชม. 3. ประเมิน V/S โดยเฉพาะอุณหภูมิ ทุก 4 ชม. รายงานแพทย์ทันทีถ้า Temp $> 38^{\circ}\text{C}$ 4. ติดตาม CBC, Differential count, Inflammatory markers (CRP, ESR) ตามแผนรักษา 5. ตรวจสอบประวัติวัคซีนและจัดทำให้ครบ: Pneumococcal, Meningococcal, Hib, Influenza 6. แนะนำหลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ที่มีการติดเชื้อ 7. สอนผู้ปกครองล้างมือ 7 ขั้นตอน และสังเกตสัญญาณการติดเชื้อ



แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก
(Clinical Nursing Practice Guideline : CNPG)

เลขหน้า 12/17

เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยโรค Thalassemia ในเด็ก

รหัสเอกสาร CNPG-Thalassemia

ข้อวินิจฉัยการพยาบาล	ข้อมูลสนับสนุน	วัตถุประสงค์ทางการพยาบาล	เกณฑ์การประเมินผล	กิจกรรมการพยาบาล
5. ความรู้ไม่เพียงพอเกี่ยวกับโรคและการดูแลตนเองเนื่องจากขาดข้อมูลและประสบการณ์ในการดูแลโรคเรื้อรัง	- S: "ไม่แน่ใจว่าลูกต้องกินยาอะไร ต้องระวังอะไร" - S: "โรคนี้น่ากลัวไหม ต้องรับเลือดตลอดไปเลยไหม" - O: ผู้ปกครองตอบคำถามเรื่องโรคได้ไม่ถูกต้อง - O: ประวัติหยุดยาขับเหล็กเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์ - O: ไม่มาตามนัดสม่ำเสมอ	1. ผู้ปกครอง/ผู้ป่วยมีความรู้เรื่องโรคและการดูแลเพิ่มขึ้น 2. ผู้ปกครองสาธิตการให้ยาขับเหล็กได้ถูกต้อง 3. ผู้ป่วยมาตามนัดสม่ำเสมอ	- ตอบคำถามเรื่องโรค การรักษา และการดูแลได้ถูกต้อง $\geq 80\%$ - สาธิตการให้ยาขับเหล็กได้ถูกต้อง - บอกอาการที่ต้องรีบมาพบแพทย์ได้ ≥ 3 ข้อ - มาตามนัด 100%	1. ประเมินความรู้พื้นฐานก่อนสอน (Pre-test / ถามตอบ) 2. ให้ความรู้เรื่องโรคธาลัสซีเมีย: พยาธิสภาพ สาเหตุ การถ่ายทอดทางพันธุกรรม 3. สอนวิธีใช้ยาขับเหล็ก Deferoxamine: ขนาดยา เวลา วิธีละลาย ผลข้างเคียง 4. แนะนำอาหาร: หลีกเลี่ยงธาตุเหล็กเสริม ดื่มน้ำมากๆ งดชา/กาแฟขณะกินยาขับเหล็ก 5. สอนสังเกตอาการฉุกเฉิน: ไข้สูง เหนื่อยมาก ชีตเพิ่ม ดีซ่าน ปัสสาวะสีน้ำตาล 6. มอบเอกสาร/คู่มือภาษาไทยที่เข้าใจง่าย 7. นัดหมายระบุวันนัด และระบบ Hosxp ให้ชัดเจน 9. ประเมินความเข้าใจหลังสอนด้วยการถามตอบและ Return demonstration



แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก
(Clinical Nursing Practice Guideline : CNPG)

เลขหน้า 13/17

เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยโรค Thalassemia ในเด็ก

รหัสเอกสาร CNPG-Thalassemia

ข้อวินิจฉัยการพยาบาล	ข้อมูลสนับสนุน	วัตถุประสงค์ทางการพยาบาล	เกณฑ์การประเมินผล	กิจกรรมการพยาบาล
6. ความวิตกกังวล เนื่องจากการเจ็บป่วยเรื้อรัง ความไม่แน่นอนของโรค และภาระค่าใช้จ่าย	- S: "กังวลมากกว่าลูกจะเป็น ยังไง จะได้เรียนหนังสือใหม่ ค่าใช้จ่ายแพงมาก" - S: ผู้ป่วย: "กลัวเจาะเลือด ไม่อยากมาโรงพยาบาล" - O: ผู้ปกครองซักถามบ่อย ดูเป็นห่วง สิ้นหัวใจวิตกกังวล - O: ผู้ป่วยร้องไห้ต่อต้านการทำหัตถการ - O: มีปัญหาทางการเงินในการเดินทางมาโรงพยาบาล	1. ผู้ปกครอง/ผู้ป่วย มีความวิตกกังวลลดลง 2. ผู้ปกครองจัดการกับความเครียดจากโรคเรื้อรังได้ดีขึ้น 3. ผู้ป่วยให้ความร่วมมือในการทำหัตถการดีขึ้น	- ผู้ปกครองบอกว่าวิตกกังวลลดลงหลังได้รับข้อมูลและการสนับสนุน - ผู้ป่วยยอมรับหัตถการโดยไม่ต้องเบี่ยงเบนความสนใจน้อยลง - ผู้ปกครองบอกสิทธิการรักษาและแหล่งสนับสนุนได้	1. รับฟังความกังวลอย่างตั้งใจ ไม่รีบร้อนหรือตัดสิน 2. ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงกับความกังวล อธิบายแผนการรักษาและเป้าหมาย 3. ใช้เทคนิค Distraction ในเด็กขณะทำหัตถการ: เล่านิทาน ดูการ์ตูน ฟังเพลง ให้รางวัล 4. แนะนำสิทธิการรักษา: บัตรทอง สิทธิคนพิการ กองทุนโรครายาก 5. ประสานนักสังคมสงเคราะห์กรณีมีปัญหาทางสังคม/เศรษฐกิจ 7. ให้กำลังใจและชื่นชมความพยายามของผู้ปกครองในการดูแลผู้ป่วย



แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก
(Clinical Nursing Practice Guideline : CNPG)

เลขหน้า 14/17

เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยโรค Thalassemia ในเด็ก

รหัสเอกสาร CNPG-Thalassemia

ข้อวินิจฉัยการพยาบาล	ข้อมูลสนับสนุน	วัตถุประสงค์ทางการพยาบาล	เกณฑ์การประเมินผล	กิจกรรมการพยาบาล
7. แผนการจำหน่าย (Discharge Planning) ด้านการรักษาและยา D - Diagnosis M - Medication	- โรคธาลัสซีเมียชนิด รับเลือดเป็นประจำ (TDT) - ค่า Ferritin ล่าสุด: ng/mL - ยาขับเหล็กที่ได้รับ: Deferasirox / Deferoxamine - จำนวนครั้งรับเลือดสะสม: สัปดาห์ละ 1 ครั้ง - วันรับเลือดล่าสุด:	1. ผู้ปกครองรู้จักยาทุก ชนิดที่บุตรได้รับ 2. ผู้ปกครองสามารถ ให้ยาขับเหล็กได้	- บอกชื่อยา ขนาด เวลา กิน ผลข้างเคียงได้ถูกต้อง - สาธิตละลายยาขับเหล็ก และให้ยาได้ถูกต้อง	1. (D) อธิบายโรคธาลัสซีเมีย สาเหตุ พยาธิสภาพ และการดำเนินโรคในภาษาที่เข้าใจง่าย 2. (M) มอบ Discharge Medication List ระบุ: ชื่อยา ขนาด วิธีกิน เวลา ผลข้างเคียง 3. (M) สอนและสาธิต Return Demo การให้ Deferasirox: ละลายยาในน้ำ 100 mL ดื่มก่อนอาหาร 30 นาที 4. (M) ย้ำ: ไม่หยุดยาขับเหล็กเองเด็ดขาด แม้อาการดีขึ้น 5. (M) แนะนำวิตามิน E และ Folic acid เสริม ตามแผนการรักษา 6. (M) ทบทวนยาที่ต้องกินต่อเนื่องที่บ้านทุกรายการ 7. (M) แนะนำช่องทาง Telemedicine กรณีอยู่ไกลและมีคำถาม



แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก
(Clinical Nursing Practice Guideline : CNPG)

เลขหน้า 15/17

เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยโรค Thalassemia ในเด็ก

รหัสเอกสาร CNPG-Thalassemia

ข้อวินิจฉัยการพยาบาล	ข้อมูลสนับสนุน	วัตถุประสงค์ทางการพยาบาล	เกณฑ์การประเมินผล	กิจกรรมการพยาบาล
แผนการจำหน่าย (Discharge Planning) ด้านสิ่งแวดล้อมและการ รักษาและสุขภาพ E - Environment, T - Treatment H Health	- บ้านอยู่ห่างโรงพยาบาล ปากช่องนานา: กม. - ผู้ดูแลหลัก: - ประวัติภาวะแทรกซ้อน: - กิจกรรมที่ทำได้ตอน จำหน่าย:	1. ผู้ปกครองเตรียมสิ่ง แวดล้อมที่บ้านเหมาะสม 2. ผู้ปกครองติดต่อทีม พยาบาลได้เมื่อมีปัญหา 3. ผู้ป่วยทำกิจกรรมตาม ระดับอาการได้เหมาะสม	- บ้านมีบริเวณสะอาด มีอากาศถ่ายเท ไม่แออัด - บอกอาการฉุกเฉินที่ต้องมา ER ได้ถูกต้อง ≥ 4 ข้อ - ทำกิจกรรมได้ไม่เกิดอันตราย	1. (E) แนะนำการจัดสิ่งแวดล้อมที่บ้าน: สะอาด อากาศถ่ายเท หลีกเลี่ยงฝุ่น/ควัน 2. (E) แนะนำหลีกเลี่ยงการพาผู้ป่วยไปในที่แออัด หรือสัมผัสผู้ป่วยโรคติดเชื้อ 3. (T) สอนอาการที่ต้องมา ER ทันที: ไข้สูง $> 39^{\circ}\text{C}$, เหนื่อยมากผิดปกติ, ชีตเพิ่มอย่างรวดเร็ว, ดีซ่าน, ปัสสาวะสีน้ำตาล/น้ำตาลเข้ม, ปวดท้องรุนแรง 4. (T) สอนอาการที่ต้องโทรปรึกษาก่อนมา: มีไข้ต่ำๆ, เหนื่อยมากขึ้นกว่าปกติ, ผื่น 5. (H) แนะนำกิจกรรมที่เหมาะสม: เดินระยะสั้น เล่นเบาๆ หลีกเลี่ยงกีฬาที่ใช้แรงมาก 6. (H) แนะนำการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอ ≥ 8 ชม./วัน ในเด็กวัยเรียน



แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก
(Clinical Nursing Practice Guideline : CNPG)

เลขหน้า 16/17

เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยโรค Thalassemia ในเด็ก

รหัสเอกสาร CNPG-Thalassemia

ข้อวินิจฉัยการพยาบาล	ข้อมูลสนับสนุน	วัตถุประสงค์ทางการพยาบาล	เกณฑ์การประเมินผล	กิจกรรมการพยาบาล
แผนการจำหน่าย (Discharge Planning) การดูแลต่อเนื่องและ ด้านอาหาร O - Outpatient Follow-up, D - Diet	- วันนัดครั้งต่อไป: - ระบบที่ลงทะเบียน: คลินิกธาลัสซีเมีย / Hosxp - การรับประทานอาหาร ประจำ	3. ผู้ปกครองวางแผน Follow-up ได้ 2. ผู้ปกครองทราบวันนัด และมาตามนัด 3. ผู้ปกครองรู้ข้อห้ามด้าน อาหารที่เหมาะสม	- ผู้ปกครองบอกวันนัด ครั้งต่อไปได้ถูกต้อง - ผู้ปกครองมีเบอร์โทร ในมือถือ - บอกอาหารที่ควรหลีกเลี่ยง ได้ถูกต้อง ≥ 3 ข้อ	1. (O) กำหนดนัด Follow-up บันทึกรวันนัดในสมุดนัด + ระบบ Hosxp 2. (O) มอบเบอร์โทรติดต่อ: ห้องพยาบาลกุมารเวชกรรม รพ.ปากช่องนานา 3. (D) แนะนำอาหาร: หลีกเลี่ยงอาหารเสริมธาตุเหล็ก เช่น ตับ เลือด อาหารทะเล เสริมธาตุเหล็ก; หลีกเลี่ยงชา กาแฟขณะกินยาขับเหล็ก

	แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก (Clinical Nursing Practice Guideline : CNPG)	เลขหน้า 17/17
	เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยโรค Thalassemia ในเด็ก	รหัสเอกสาร CNPG-Thalassemia

6.4 จำนวนพยาบาลที่ใช้

พยาบาล, ผู้ช่วยพยาบาล และผู้ช่วยเหลือคนไข้ที่อยู่ในเวร

6.5 แนวทางการจัดสรรทรัพยากร

1. จัดตารางการปฏิบัติงาน จำนวนเจ้าหน้าที่เพียงพอ อัตรากำลัง RN 4 PN 1 NA 1
2. จัดเตรียมเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อเตรียมให้การพยาบาลเมื่อผู้ป่วยเด็กเกิดภาวะแทรกซ้อนขณะและหลังให้เลือด
3. ประสานศูนย์เครื่องมือแพทย์เครื่องควบคุมอัตราไหลของเลือดและส่วนประกอบของเลือด
4. จัดสถานที่สำหรับให้ผู้ป่วยได้นอนพักในระหว่างรอและระหว่างให้เลือด

7. การบันทึกข้อมูลและเอกสารที่ใช้ (Records & Form)

7.1 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน

1. แบบบันทึกสัญญาณชีพการให้เลือด ตามแนวทางปฏิบัติของโรงพยาบาล

8. เอกสารอ้างอิง

กรองแก้ว ทรัพย์ประเสริฐวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก.

(2568). ผลของโปรแกรมการสอนต่อความรู้และพฤติกรรมการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยเด็กโรคธาลัสซีเมีย

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว. Bu J Med Vol.12 No.1, 15-28.

<https://he01.tci-thaijo.org/index.php/BJmed/article/view/274201/187655>

แนวทางการวินิจฉัยและการรักษาโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย Clinical practice guidelines for diagnosis and management of thalassemia syndromes

http://www.thalassemia.or.th/thal-book/CPG_Thalassemia_2014-content.pdf

สำนักวิชาการแพทย์กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข. (2560). แนวทางการดูแลผู้ป่วยธาลัสซีเมียในเวชปฏิบัติทั่วไป Guidelines for the care of thalassemia patients in general practice

<https://www.biogenetech.co.th/wp-content/uploads/2018/01/Guidelines-for-thalassemia-care.pdf>

